AI × 医学教育

AI時代の医療者に求められること

AIと一緒に働く未来 — 便利だけど万能じゃない

参考文献

2026-03-26 · AI（Claude）作成・主な出典は原典で確認

知っていますか？この数字

「診療でAIを使っているアメリカの医師が、80%を超えました。」

— AMA（アメリカ医師会）2026年調査（医師1,692人）より

AIはもう「今の話」です

- 2023年には38%だったのが、3年で**2倍以上**に
- **4人に3人以上**が「AIは患者さんをケアする自分の力を高める」と考えている

AIはもう"未来の話"ではなく、"今の話"です。でも、AIって本当にすごいの？ 怖くないの？ 今日の15分で、一緒に考えましょう。

今日のゴール

この15分の後、あなたは：

1. AIの**得意なこと・苦手なこと**がわかる
2. AIが**間違える理由**をイメージできる
3. **自分の仕事でAIとどう付き合うか**考えられる

AIが得意なこと

AIの得意技	身近な例え
大量のデータを素早く処理	何万冊の本を一瞬で検索できる図書館司書
パターンを見つける	「この検査値の組み合わせは要注意」と気づく
24時間休まず働く	夜勤も疲れも関係なし
同じ作業を正確に繰り返す	書類の転記やデータ入力のプロ

AIが苦手なこと

AIの苦手	なぜ苦手？
人の気持ちを理解する	「不安そうな表情」「声のトーン」は数字にできない
文脈を読む	「この患者さんは家族との関係が複雑で…」が伝わらない
責任を取る	判断の最終責任は必ず人間にある
「なんとなくおかしい」に気づく	ベテランの直感や経験は数値化できない

たとえるなら、AIは「ものすごく優秀だけど、空気が読めない新人スタッフ」。
データの処理は速いけど、患者さんの涙の意味はわからない。

AIも「間違える」— 知っておいてほしい話

最新の研究（PNAS 2025年発表ほか）で、AIの「くせ」がわかってきました：

1. 「何もしない」を選びがち（不作為バイアス）
2. 最初の情報に引きずられる（アンカリング）
3. 聞き方で答えが変わる（フレーミング効果）

PNASの研究は、道徳的なジレンマ場面でAIの答えを調べたものです。医療現場への当てはまりは、まだ推測を含みます。

くせ1「何もしない」を選びがち

不作為バイアス

例え話：廊下で患者さんが転びそうになっている。

> *手を出して支えたら → もしケガさせたら自分のせい？ 何もしなかったら → たまたま転んだだけ？*

道徳的なジレンマの実験では、AIは人より「何もしない」を選びがちでした。でも医療では、**「何もしないこと」も判断であり、責任がある**　。

くせ2とくせ３

くせ2: 最初の情報に引きずられる（アンカリング）

- 最初に見た数字に影響されて、後から入った情報を軽視してしまう
- 人間にもある「くせ」で、医療用のAIにも同じ傾向が報告されています（npj Digital Medicine 2025）

くせ３: 聞き方で答えが変わる（フレーミング効果）

- 「成功率90%の手術です」と聞くと安心するけど、「10人に1人は失敗します」と聞くと不安になる
- 同じことなのに、伝え方で印象が変わる。AIも、同じ質問の聞き方で答えが変わることがある

だから大切なこと

AIの答えを「そのまま信じる」のではなく、「本当かな？」と立ち止まる。

これが、AI時代に一番大切なスキルです。

実際の医療現場ではどう使われている？

アメリカの病院の最新事例（ HIMSS26で講演）

BJC Healthcareという病院グループでは：

- 既存の死亡リスクモデルを補う形で、患者さんの記録を読み込み
- AIが「この患者さんは今後のケア計画について話し合うタイミングかもしれません」と**提案**
- 最終判断は必ず**医師やケアチームが行う**

ポイント: AIは「提案する」だけ。「決める」のは人間。

チーム医療の中の AI

これまで	これから
スタッフだけでカンファレンス	AIが事前に情報を整理してくれる
手作業でデータを集計	AIが自動で傾向をまとめてくれる
経験と勘で優先度を判断	AIが「見落とし」を減らす手伝い

AIは**チームの一員**。でも、リーダーは常に**人間**です。

みんなで考えよう(グループワーク 3分)

3-4人のグループで話し合ってみましょう。

テーマ:あなたの業務の中で...

1. **AIに手伝ってもらいたいこと** は？
2. **絶対に人がやるべきこと** は？

考え方のコツ:「AIに任せて楽になること」と「人間だからこそ意味があること」を分けてみよう。

考えるヒント

- 毎日繰り返しているデータ入力や記録作業は？
- 「ダブルチェック」で時間がかかっている業務は？
- 患者さんやご家族と直接向き合う場面は？
- 「この仕事、間違えたら大変」という判断業務は？

全体共有（1分）: 各グループから1つずつ共有してください。

「AIに任せたい」と「人がやるべき」の**境界線**が曖昧なものこそ面白い。「迷うこと」自体が大切な学びです。

今日の3つのポイント

	ポイント	ひとことで
1	AIは便利だけど万能じゃない	得意なことと苦手なことがある
2	AIも間違える・偏る	「本当かな？」と立ち止まる習慣が大切
3	人間にしかできないことがある	患者さんに寄り添えるのはあなただけ

覚えておいてほしいこと

テクノロジーは変わります。でも、患者さんの手を
握れるのは、あなただけです。
AIが得意なことはAIに任せて、あなたにしかできな
いこと ― 笑顔、声かけ、気づき、寄り添い ― に、
もっと時間を使えるようになる。
それが「AIと一緒に働く未来」です。

振り返りと次のステップ

振り返りの問い

- 今日聞いた話の中で、1つだけ誰かに伝えるとしたら、何を選びますか？

次のステップ

- 日常業務の中で「これ、AIに手伝ってもらえないかな？」とアンテナを立ててみる
- AIの答えに接したとき「本当かな？」と一度立ち止まってみる
- わからないことがあれば、いつでも相談してください

参考文献

1. AMA (2026) — More than 80% of physicians use AI professionally: AMA survey.
https://www.ama-assn.org/practice-management/digital-health/more-80-physicians-use-ai-professionally-ama-survey
2. Healthcare IT News (2026) — BJC Healthcare ACO, マルチAIエージェントによる臨床意思決定支援（HIMSS26発表）。
https://www.healthcareitnews.com/news/how-multi-ai-agents-can-improve-clinical-decision-support
3. PNAS (2025) — Large language models show amplified cognitive biases in moral decision-making（道徳的ジレンマでの不作為バイアス等）。
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2412015122
4. npj Digital Medicine (2025) — Cognitive bias in clinical large language models.
https://www.nature.com/articles/s41746-025-01790-0

ファシリテーター向けメモ

準備物

- [ ] プロジェクター or モニター
- [ ] タイマー（グループワーク3分計測用）
- [ ] 付箋（グループワーク用、任意）

進行のコツ

- **「知っていますか？この数字」**：「80%」の数字を最初に見せてインパクトを与える。「自分もAI使ったことある？」と問いかけて参加感を出す
- **「AIが苦手なこと」**：「空気が読めない新人スタッフ」の例えは笑いを誘いやすい。場が和んだところで「でも仕事は速い」と続ける
- **「AIも間違える」〜「くせ」の 3枚**: バイアスの話は難しくなりがちなので、必ず例え話で説明する。「転びそうな患者さん」の例は全職種がイメージしやすい

ファシリテーター向けメモ（続き）

- **「実際の医療現場」～「チーム医療の中の　AI」:**「AIは提案、人間が決定」を繰り返し強調する
- **「みんなで考えよう」：**グループワークでは「正解はない」ことを最初に伝える。迷うこと自体が学び
- **「覚えておいてほしいこと」：**最後のメッセージは落ち着いたトーンで。「あなたが大切」を心を込めて

3/21版との違い（聞かれた場合）

- 3/21版：「AIエージェント」の概念紹介が中心（AIチームの比喩）
- 今回：「最新データで見るAIの光と影」がテーマ。AIの限界やバイアスにも踏み込んだ内容
- 両方受けた方には：「前回は"AIって何ができるか"、今回は"AIとどう付き合うか"」と伝える